

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESI UROLOGI

1	No. Station	1A
2	Judul Station	BPH – anestesi spinal
3	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan evaluasi pra anestesi, diagnosis dan problem aktual – potensial, keterampilan klinis, monitoring dan manajemen penyulit, komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5	Kompetensi	1. Evaluasi pra anestesi 2. Diagnosis dan problem aktual – potensial 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen pasca anestesia 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Anestesi bedah saraf 3. Anestesi regional dan manajemen nyeri 4. Anestesi bedah toraks 5. Anestesi pediatrik 6. Anestesi kegawatdaruratan 7. Anestesi urologi 8. Anestesi untuk penyakit khusus (endokrin, metabolik, penyulit kardiovaskuler) 9. Anestesi bedah kepala leher 10. Anestesi bedah rawat jalan / luar kamar bedah 11. Anestesi pada prosedur invasif minimal 12. Terapi intensif
7	Instruksi untuk peserta	<u>Skenario Klinik</u> Seorang laki-laki usia 65 tahun dengan berat badan 50 kg datang ke IGD RS dengan keluhan utama buang air kecil tidak tuntas sejak 3 bulan yang lalu. Pasien didiagnosis BPH direncanakan operasi TURP. <u>Instruksi Untuk Peserta:</u> 1. Lakukan evaluasi pra anestesi terhadap pasien! 2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien! 3. Lakukan tindakan anestesi spinal pada pasien! 4. Operasi berlangsung lama dan terjadi perdarahan. Sebutkan monitoring dan manajemen penyulit pada pasien!
8	Instruksi untuk penguji	<u>Instruksi Umum</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian !

		3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor global rating sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta
		dalam instruksi penguji ! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE ATI <u>Intruksi Khusus</u> 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan evaluasi pra anestesi yang dilakukan peserta: Penguji memberikan data bila diminta oleh peserta Anamnesis 1. <i>Allergies</i> = tidak ada 2. <i>Medications</i> = tidak ada 3. <i>Past medical history</i> = Riwayat penyakit dahulu tidak pernah sakit yang serius 4. <i>Last meal</i> = dipuaskan 6 jam sebelum operasi 5. <i>Events</i> = buang air kecil tidak lampias sejak 3 bulan yang lalu Pemeriksaan fisik Tanda vital: Sen cm Tekanan darah : 100/70 mmHg Laju nadi : 90 x/menit Laju napas : 20 x/ menit SpO2 : 97% Temperatur 36.5°C Pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal Pemeriksaan penunjang Hasil laboratorium • Darah rutin • Hb 12 gr/dl • Ht 36 % • Leukosit 7800/mm² • Trombosit 310.000/mm²

		Faal hemostasis • PT 10.9 (12.2) • APTT 35.8 (30.7) • INR 1.5 Darah kimia • Na 140 meq/L • Kalium 3.8 meq.L • Cl 100 mmol/L • Glukosa 98 mg/dl USG • Ukuran prostat 80 gram EKG • Dalam batas normal 2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini Problem aktual 1. Geriatri 2. Ukuran prostat besar (>60 gram) Potensial problem 3. Sindrom TURP 4. Perdarahan 5. Hipotermi 6. Ruptur vesika urinaria 7. Septikemia 8. DIC 9. Retensi bekuan darah (<i>clotting</i>) 10. Anestesi spinal tinggi 3. Penguji menilai peserta melakukan keterampilan tindakan anestesi spinal 1. Memeriksa kesiapan alat dan obat yang diperlukan, menentukan jenis dan ukuran jarum yang akan digunakan 2. Memeriksa kesiapan alat emergensi 3. Memasang monitor standar dan akses intravena 4. Melakukan interpretasi kondisi pasien berdasar hasil monitor 5. Memposisikan pasien <i>lateral decubitus</i> atau duduk 6. Mengidentifikasi celah L3-L4, L4-L5, L5-S1 dengan menggunakan garis Tuffier atau teknik lain, kemudian menentukan titik punksi (pendekatan median atau paramedian) 7. Cuci tangan, memakai gaun bedah steril dan handscoen steril 8. Melakukan tindakan asepsis dan antisepsis pada <i>landmark</i> yang sudah ditentukan dan menutupnya
--	--	--

		dengan duk lubang steril - Melakukan infiltrasi anestesi local pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum spinal - Melakukan penusukan jarum spinal, mencabut mandarin dan memastikan ujung jarum berada pada ruang subaraknoid ditandai dengan keluarnya LCS - Memasukkan obat anestesi local secara perlahan - Memastikan blok spinal berjalan baik, target blok adekuat 4. Penguji menilai monitoring dan manajemen penyulit pasien ini: - Melakukan pemeriksaan tanda vital dan perkiraan perdarahan - Suplementasi oksigen kalau perlu persiapan intubasi - Resusitasi cairan, pemeriksaan lab dan persiapan transfusi darah - komunikasi dengan operator <i>Informed consent</i> kepada keluarga 5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta	
9	Tata letak ruangan	Model kamar operasi	
10	Kebutuhan laboran	Jumlah laboran : 1 Tugas laboran : sebagai penata anestesi, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan spinal anestesi	
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Peralatan ruang operasi - Manekin spinal - Jarum spinal 25,26,27 - Nampan alat - Duk lobang - Cawan 2 buah dengan label povidone iodine, alkohol	1 set 1 buah @ 5 buah 1 buah 1 buah 1 set
		- Korentang - Kassa - Topi dan masker - Sarung tangan steril 6,5,7,7,5 - Alkohol 70 % - Povidone iodine 10 % - Sduit 5 cc, 10 cc - Plester - Gunting - Obat anestesi lokal (lidocaine,	1 buah 5 buah @ 1 kotak @ 10 buah 1 botol 1 botol @ 5 buah 2 set 1 buah 1 buah

		bupivacaine, ropivacaine) - Tensimeter - Stetoskop - Thermometer - Nasal canul - Simple mask -	1 buah 1buah 1 buah 1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin spinal 1 buah	
13	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	
14	Referensi	Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD, editors. Morgan and Mikhail's clinical anesthesiology. 6 ed. New York: McGraw Hill Professional; 2018.	

RUBRIK ACTUAL MARK
OSCE STATION REGIONAL DAN MANAGEMEN NYERI

Aspek yang dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra Anestesi 1. Anamnesis • <i>Allergies</i> • <i>Medications</i> • <i>Past medical history</i> • <i>Last meal</i> • <i>Events</i> yang lalu 2. Pemeriksaan fisik • Tanda vital • Pemeriksaan fisik dalam batas normal 3. Pemeriksaan penunjang • Laboratorium - Darah rutin - Faal hemostasis - Darah kimia • USG • EKG	Kandidiat tidak melakukan evaluasi pra anestesi	-	Peserta ujian melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang namun TIDAK LENGKAP	Peserta ujian melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang secara LENGKAP	2	
2. Problem aktual dan problem potensial Problem aktual 1. Geriatri 2. Ukuran prostat besar (>60 gram) Potensial problem 3. Sindrom TURP	Peserta ujian tidak menyampaikan problem aktual dan potensial	Peserta ujian menyampaikan 1-3 problem aktual dan potensial	Peserta ujian menyampaikan 4-6 problem aktual dan potensial	Peserta ujian menyampaikan 7-10 problem aktual dan potensial	2	

4. Perdarahan 5. Hipotermi 6. Ruptur vesika urinaria 7. Septikemia 8. DIC 9. Retensi bekuan darah (<i>clotting</i>) 10. Anestesi spinal tinggi						
3. Keterampilan klinis Keterampilan tindakan anestesi spinal 1. Memeriksa kesiapan alat dan obat yang diperlukan, menentukan jenis dan ukuran jarum yang akan digunakan 2. Memeriksa kesiapan alat emergensi 3. Memasang monitor standar dan akses intravena 4. Melakukan interpretasi kondisi pasien berdasar hasil monitor 5. Memposisikan pasien <i>lateral decubitus</i> atau duduk 6. Mengidentifikasi celah L3-L4, L4-L5, L5-S1 dengan menggunakan garis Tuffier atau teknik lain, kemudian menentukan titik punksi (pendekatan median atau paramedian) 7. Cuci tangan, memakai gaun bedah steril dan handscoen steril 8. Melakukan tindakan aseptis dan antisepsis pada <i>landmark</i> yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan duk lubang steril 9. Melakukan infiltrasi anestesi local pada celah	Peserta tujuan tidak melakukan tindakan anestesi spinal	Peserta ujian melakukan tindakan anestesi spinal TIDAK LENGKAP dan TIDAK URUT. Anestesi spinal tidak berhasil dilakukan (LCS tidak keluar).	Peserta ujian melakukan tindakan anestesi spinal TIDAK LENGKAP dan TIDAK URUT. Anestesi spinal berhasil dilakukan (LCS keluar).	Peserta ujian melakukan tindakan anestesi spinal LENGKAP dan URUT	3	

yang akan dilakukan penusukan jarum spinal 10. Melakukan penusukan jarum spinal, mencabut mandarin dan memastikan ujung jarum berada pada ruang subaraknoid ditandai dengan keluarnya LCS 11. Memasukkan obat anestesi local secara perlahan 12. Memastikan blok spinal berjalan baik, target blok adekuat						
4. Monitoring dan manajemen penyulit 1. Melakukan pemeriksaan tanda vital dan perkiraan perdarahan 2. Suplementasi oksigen kalau perlu persiapan intubasi 3. Resusitasi cairan, pemeriksaan lab dan persiapan transfusi darah 4. komunikasi dengan operator 5. <i>Informed consent</i> kepada keluarga	Peserta ujian tidak melakukan monitoring dan manajemen penyulit.	Peserta ujian menyebutkan 2 monitoring dan manajemen penyulit.	Peserta ujian menyebutkan 4 monitoring dan manajemen penyulit.	Peserta ujian menyebutkan 5 monitoring dan manajemen penyulit.	2	
5. Komunikasi dan perilaku profesional 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat pada pasien 5. Mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4 poin yang diminta	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan poin-poin secara lengkap	1	

TOTAL SKOR	
------------	--